

4.3. ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

1. FICHA TÉCNICA

- **Nombre de la escala:** Problem- Solving/Decision-Making Skills Subscale.
- **Autores:** Adaptación española de la subescala Decision making/Problem solving del Life-skills Development Scale de Darden, Ginter y Gazda (1996).
- **Nº de ítems:** 8.
- **Aplicación:** Se puede aplicar de forma individual o colectiva.
- **Duración:** Unos 5 minutos.
- **Finalidad:** Evaluar la percepción de los adolescentes sobre su propia habilidad para la planificación y la toma de decisiones.
- **Tipificación:** Baremación en centiles según el sexo y la edad.
- **Material:** Manual, escala y baremos.

2. LA CAPACIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES: SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ADOLESCENTE

Una simple exploración en la web del término decision making (toma de decisiones) mediante un buscador cualquiera da como resultado un elevadísimo número de páginas en las que este término aparece, casi 88 millones de entradas, más incluso que el término self-esteem (autoestima). Parece que los humanos concedemos mucha importancia a la habilidad para tomar decisiones, aunque no exista un consenso claro en las perspectivas que diferentes autores asumen, ya que algunos se centran en la explicación de la toma de decisiones por la vía racional mientras que otros ponen el énfasis en la instintiva (Gigerenzer, 2008).

En general, tendemos a pensar que nuestras decisiones son el resultado de un proceso de pensamiento que se basa en la lógica y nos lleva por una serie de pasos secuenciales que, salvados de forma coherente, nos guiarán a la mejor decisión posible. La frase anterior es un buen ejemplo de esa vía racional en la toma de decisiones, en la línea de pensamiento de Kahneman y Tversky. Los procesos de planificación, la reflexividad, el análisis detallado de las alternativas, etc., forman parte del pensamiento humano y precisamente en la adolescencia nos encontramos con un momento evolutivo especialmente propicio para el desarrollo de estas capacidades.

El desarrollo de la autonomía de los chicos y las chicas es enorme a partir de la pubertad. La búsqueda de sensaciones, la exploración de otros contextos que van más allá de la familia, las relaciones con otros chicos y chicas, etc., hacen que aprender a tomar buenas decisiones se convierta en una de las tareas centrales en esta etapa evolutiva. Esta realidad, y el deseo de padres/madres y educadores/as de que los más jóvenes elijan bien, apoyan la importancia de estudiar el desarrollo de estas habilidades a lo largo de esta etapa.

El proceso racional para tomar decisiones requiere de la identificación y análisis del problema, de la ponderación de los criterios de decisión, de la búsqueda de información, de la génesis y evaluación de diferentes alternativas de solución, de la puesta en marcha de la decisión y de su evaluación posterior. Y cada vez existen más evidencias que apuntan a que la adquisición de estas habilidades durante la adolescencia no es tarea fácil. Esto es debido, entre otras razones, al desequilibrio que existe entre las conexiones nerviosas cognitivas y motivacionales que provocan cierta vulnerabilidad y aumentan la impulsividad y la asunción de riesgos durante esta etapa del desarrollo. Además, las vías neuronales que unen la corteza órbita-frontal y algunas estructuras límbicas, están desarrollándose durante la segunda década de la vida (Goldberg,

2001), lo cual hace que el control cognitivo y la inhibición conductual y emocional aún no estén plenamente adquiridos. Sin duda, tomar algunas decisiones con un cerebro aún inmaduro puede ser una tarea complicada durante los años inmediatos a la pubertad. A nivel emocional, por ejemplo, la maduración cerebral transformará con el tiempo la impulsividad propia de la adolescencia temprana en reflexividad (Weinberger, Elvevag y Giedd, 2005). Esa inmadurez del lóbulo frontal hace más vulnerables a chicos y chicas y provoca que cometan fallos en el proceso cognitivo de planificación y formulación de estrategias, el cual requiere de una memoria de trabajo no completamente desarrollada en estos primeros años (Swanson, 1999).

Como señala Oliva (2007), la inmadurez prefrontal está relacionada con la toma de decisiones. En concreto, la corteza prefrontal ventromedial tiene un protagonismo importante en esta habilidad, algo que se ha puesto de manifiesto en los estudios con pacientes que presentan lesiones en dicha zona, ya que estos sujetos tienen dificultades.

Para anticipar las consecuencias futuras, tanto positivas como negativas, de su conducta, y para valorar los riesgos de una situación (Bechara, Damasio y Damasio, 2003). Esa relación con la toma de decisiones destaca la relevancia que la inmadurez prefrontal tiene para entender la mayor impulsividad e implicación de chicos y chicas adolescentes en conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad, el consumo de drogas o los comportamientos antisociales. En este sentido, es importante destacar el papel que desempeñan también otros circuitos neuronales aún en desarrollo: los que se ocupan del procesamiento de recompensas y de los aspectos emocionales en la toma de decisiones.

Si la corteza prefrontal dista mucho de haber madurado por completo al inicio de la adolescencia, es de esperar que, tal como hemos comentado, las facultades que dependen de ella presenten algunas limitaciones en ese momento, pero que vayan mejorando con el avance en esta etapa evolutiva. No obstante, las habilidades de razonamiento lógico no tardan demasiado en consolidarse y a los 15 años estarán a un nivel muy parecido a la de los adultos, incluso en la percepción de riesgos ante algunas conductas o la valoración de costes y beneficios en diferentes actividades (Steinberg, 2005).

Aunque hemos hablado de las variables del desarrollo del propio sujeto como factores que influyen en la planificación y toma de decisiones, no debemos olvidar que el contexto también ejerce una importante influencia en estas habilidades. Y no hablamos sólo del grupo de iguales y su impacto en las decisiones del adolescente, sino también del contexto familiar y la historia evolutiva previa que se ha forjado en ese escenario de desarrollo. La investigación también ha aportado datos en esta línea de influencia indicando, por ejemplo, que la sensibilidad de los padres y las madres se relacionan positivamente con las habilidades del adolescente. Los chicos y chicas con madres y padres más sensibles parecen ser aquellos que presentan un mejor desarrollo.

3. DESCRIPCIÓN Y DATOS PSICOMÉTRICOS DE LA ESCALA

La escala que presentamos procede del instrumento Life Skills Development Scale - Adolescent Form (LSDS-B) de Darden, Ginter y Gazda (1996), el cual está compuesto por 65 ítems que deben ser puntuados en una escala comprendida entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo). Esta escala original proporciona una puntuación global de eficacia, así como puntuaciones concretas de las siguientes dimensiones que componen la misma: comunicación interpersonal/habilidades para las relaciones; resolución de problemas/habilidades para la toma de decisiones; salud física/habilidades para el mantenimiento de la salud; y desarrollo de la identidad/habilidades para planteamiento de objetivos vitales.

La escala que aparece en este documento es la segunda subescala del instrumento de Darden et al. (1996) que hemos citado, y evalúa la percepción que los adolescentes tienen sobre su propia habilidad para planificar y tomar decisiones. Nuestro equipo de investigación realizó la traducción y adaptación del instrumento original en inglés al castellano.

Aunque la subescala de toma de decisiones contaba originalmente con 15 ítems, hemos realizado análisis estadísticos para comprobar la adecuación de la subescala a nuestros objetivos. Tras realizar un análisis de fiabilidad del instrumento mediante el alpha de Cronbach, estudios sobre normalidad y análisis factoriales exploratorios, hemos depurado la subescala quedarnos con 8 de los 15 ítems originales.

Teniendo en cuenta que la validez de constructo es el tipo de validez más importante y que incluye a los otros tipos de validez, elegimos el análisis factorial exploratorio para llevar a cabo la depuración de la escala. El objetivo en el presente estudio era comprobar el grado en que la escala de toma de decisiones se ajustaba a la variable que se quería evaluar. El procedimiento estadístico concreto que utilizamos ha sido el método de componentes principales con rotación oblimin directo. A continuación exponemos los resultados de dicho análisis.

En el análisis factorial exploratorio se comprobó la adecuación de la muestra para realizar el análisis mediante el test Kaiser-Meyer-Olkin ($KMO = .91$). Se siguieron los criterios de eliminar los ítems con comunalidades inferiores a .40, aquellos cuyo peso factorial más elevado era inferior a .32, los que tenían pesos superiores a .32 en más de un factor, y aquellos en los que la diferencia entre el peso factorial más elevado y el siguiente era inferior a .15. Para asegurar la estabilidad factorial también se excluyeron factores con menos de tres ítems.

La solución factorial final realizada sobre los ocho ítems que superaron los criterios anteriores reveló la existencia de un factor que explica un 57.3% de la varianza, con un autovalor de 4.58. El segundo factor presenta un autovalor menor que uno, por lo que la escala mostró claramente ser unidimensional. El gráfico de sedimentación obtenido también apoya este resultado. Los coeficientes factoriales estandarizados se presentan en la Tabla 5.

TABLA 5. COEFICIENTES FACTORIALES ESTANDARIZADOS OBTENIDO EN EL AFE.

Ítems	Coeficientes en Factor
Ítem 1	.70
Ítem 2	.74
Ítem 3	.79
Ítem 4	.76
Ítem 5	.79
Ítem 6	.81
Ítem 7	.74
Ítem 8	.66

En lo que se refiere a la fiabilidad de la escala, el procedimiento que seguido ha sido el índice de consistencia interna, alfa de Cronbach. Mediante este procedimiento se pretende saber si los elementos que componen la escala miden lo mismo que el resto de los elementos que la componen. Para la muestra total, se obtuvo un índice alfa de Cronbach de .89 para N=2327.

La versión definitiva de esta escala está compuesta por ocho ítems. El formato de respuesta sigue las indicaciones del instrumento de Darden et al. (1996), de manera que los sujetos han de puntuar entre 1 y 7 cada uno de los ítems que la componen.

4. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe responder indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en una escala que va de 1 (Nada de acuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 7.

NORMAS DE CORRECCIÓN

Deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que componen la escala. A continuación presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse. Planificación y toma de decisiones:

ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-56).

Una vez calculadas estas puntuaciones directas, pueden transformarse en puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la edad del chico o chica que haya cumplimentado el cuestionario. Los baremos se han elaborado con una muestra de adolescentes pertenecientes a las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba de la Comunidad Andaluza, cuyas características y distribución, se han descrito al inicio de este manual.

5. NORMAS DE INTERPRETACIÓN

En primer lugar, es importante indicar que la planificación y toma de decisiones es un componente de la competencia social que tiene mucho que ver con el desarrollo cognitivo. Este dato es importante tenerlo en cuenta para la interpretación de los resultados, ya que no podemos generalizar el resultado que obtengamos en la aplicación de la escala para explicar el nivel de competencia social global de un sujeto. Es decir, muchas dimensiones centrales de la competencia social quedan fuera de la información que proporciona esta escala.

También es importante tener en cuenta que las puntuaciones reflejan la percepción que tiene el propio sujeto evaluado de su propia capacidad de planificación y toma de decisiones. Es posible que algunos sujetos sobreestimen sus capacidades y que otros las infravaloren. Además, la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependerán de lo sincero que haya sido el sujeto evaluado al responder a las preguntas.

La capacidad de planificación y toma de decisiones es una habilidad que se desarrolla durante toda la adolescencia y también más allá de esta etapa. Es importante interpretar los resultados teniendo en cuenta este hecho, ya que conforme el desarrollo avanza es más probable que esta habilidad vaya aumentando en eficacia.

Finalmente, queremos resaltar el papel que las habilidades de planificación y toma de decisiones tienen en la construcción de una buena autoestima. Ya sean estas habilidades factores que influyen en el logro de una adecuada autoestima o bien, consecuencias de ésta, en ambos casos parece razonable promover el desarrollo de estas habilidades como vía para el desarrollo de competencias tanto de tipo cognitivo como social o personal.

BAREMOS 12-13 AÑOS

PUNTUACIONES DIRECTAS			
CENTILES	Chicas	Chicos	CENTILES
95	56	56	95
90	55	-	90
85	54	55	85
80	52	53	80
75	50	50	75
70	49	49	70
65	47	47	65
60	46	45	60
55	45	44	55
50	44	43	50
45	42	42	45
40	40	41	40
35	39	40	35
30	37	39	30
25	36	37	25
20	35	35	20
15	33	34	15
10	32	31	10
5	30	29	5
N	255	218	
Media	43.15	43.01	
D.t.	8.69	9.18	

BAREMOS 14-15 AÑOS

PUNTUACIONES DIRECTAS			
CENTILES	Chicas	Chicos	CENTILES
95	56	56	95
90	54	54	90
85	52	52	85
80	50	50	80
75	48	49	75
70	-	48	70
65	47	47	65
60	46	46	60
55	45	45	55
50	43	43	50
45	42	42	45
40	40	41	40
35	39	39	35
30	38	38	30
25	37	36	25
20	35	34	20
15	34	32	15
10	32	-	10
5	28	28	5
N	652	496	
Media	42.50	42.45	
D.t.	8.55	8.71	

BAREMOS 16-17 AÑOS

PUNTUACIONES DIRECTAS			
CENTILES	Chicas	Chicos	CENTILES
95	55	55	95
90	52	53	90
85	50	50	85
80	48	49	80
75	-	48	75
70	47	47	70
65	45	46	65
60	44	44	60
55	43	43	55
50	42	41	50
45	41	-	45
40	40	40	40
35	-	38	35
30	38	37	30
25	37	36	25
20	36	35	20
15	35	33	15
10	32	32	10
5	29	28	5
N	389	317	
Media	42.05	41.55	
D.t.	7.69	8.31	

Lee las siguientes frases y rodea con un círculo la opción que consideres en función de tu mayor o menor grado de acuerdo con cada una de ellas. Gracias.

Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Algo de acuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	2	3	4	5	6	7

		Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Algo de acuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Le doy vueltas a la cabeza y lo analizo todo cuando estoy intentando resolver un problema	1	2	3	4	5	6	7
2	Me pongo manos a la obra cuando decido el tipo de trabajo que quiero hacer	1	2	3	4	5	6	7
3	Cuando pienso en varias opciones, las comparo con detalle	1	2	3	4	5	6	7
4	Me gusta planearlo todo antes de tomar una decisión definitiva	1	2	3	4	5	6	7
5	Soy capaz de diseñar un buen plan de acción cuando tengo que decidir algo importante relacionado con mis estudios o mi trabajo	1	2	3	4	5	6	7
6	Considero todos los factores antes de tomar una decisión ante un problema	1	2	3	4	5	6	7
7	Utilizo la información que obtengo para descubrir diferentes soluciones a un problema	1	2	3	4	5	6	7
8	Soy capaz de resolver problemas utilizando la lógica	1	2	3	4	5	6	7

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bechara, A., Damasio, H. y Damasio, A. (2003). The role of the amygdala in decisionmaking. En *The Amygdala in Brain Function: Basic and Clinical Approaches*. Annals of the New York Academy of Sciences, 985, 356-369.
- Darden, C. A., Ginter, E. J. y Gazda, G. M. (1996). Life skills development scale - adolescent form: The theoretical and therapeutic relevance of life-skills. *Journal of Mental Health Counseling*, 18, 142-163
- Gigerenzer, G. (2008). Decisiones instintivas. La inteligencia del inconsciente. Barcelona.: Ariel.
- Goldberg, E. (2001). The executive brain: Frontal lobes and the civilized mind. Nueva York: Oxford University Press.
- Miller, J.P. y Bowen, B.E. (1993). Competency, Coping, and Contributory Life Skills Development of Early Adolescents. *Journal of Agricultural Education*, 31 (1), 68-76
- Oliva, A. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la adolescencia. *Apuntes de Psicología*, 25, 239 - 254
- Slicker, E.K., Picklesimer, B.K., Guzak, A.K. y Fuller, D.K (2005). The relationship of parenting style to older adolescent life-skills development in the United States. *Young*, 2005; 13, 227-245.
- Steinberg L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. *Trends in Cognitive Sciences*, 9, 69-74.
- Swanson, H. L. (1999). What develops in working memory? A life span perspective. *Developmental Psychology*, 35, 986-1000.
- Weinberger, D.R., Elvevag, B. y Giedd, J.N. (2005). The adolescent brain: A work in progress. Washington, DC: National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.